Педагогіка здоров’я.

Модуль 2

Д.ПЕД.Н., ПРОФЕСОР

ШТЕФАН Л.В.

МАГІСТР МЕДИЦИНИ, ПЕДАГОГІКИ, ЕКОНОМІКИ

ШЕВЧЕНКО О.С.

УІПА, ХАРКІВ, 2020





Лекція 18.

Інклюзивна освіта.

Інклюзивне навчання

План лекції
1. Інвалідність. Розподіл МСЕК на групи.
2. Запобігання дискримінації та стигматизації людей з обмеженими можливостями.
3. Допомога суспільства інвалідам, інклюзивна освіта.

Інклюзивне навчання — система освітніх послуг, гарантованих державою, що базується на принципах недискримінації, врахуванні багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників.

Інклюзивне навчання часто вважають альтернативою інтернатній системі, за якою діти з особливими освітніми потребами навчаються в спеціальних закладах освіти та змушені проживати в інтернатних відділеннях при них через їх територіальну розгалуженість.

Жодна дитина не має відчувати себе іншою та виключеною з освітніх, культурних і соціальних процесів – це головне завдання інклюзії.

Інвалідність – стійкий розлад здоров'я з порушенням функцій руху, зору та ін., з порушенням можливості виконувати дії, які вважають для цього індивідуума нормальними в залежності від вікових, статевих, соціальних і культурних факторів, часто з відсутність можливості самостійного обслуговування, пересування без візка та милиць. Люди з інвалідністю потребують соціального захисту і допомоги. Замість слова «інвалід», яке означає «непридатний», в наш час використовують термін «людина з обмеженими можливостями». А використання слова «інвалід» у принизливому значенні, а також більш різки вислови (недоумкуватий, розумово неповноцінний, жертва поліомієліту, глухонімий, прикутий до інвалідного візка, тощо) є проявами дискримінації та стигматизації, і вони неприпустимі.

Інвалідність відбувається внаслідок загального захворювання, каліцтва, трудового або професійного захворювання, поранення (контузії) під час бойових дій, в результаті нещасного випадку.

Інвалідність (2)

Ступінь постійної чи продовжуваної втрати працездатності визначає **група інвалідності**, яку визначає медико-соціальна експертна комісія (далі – СМЕК):

I – це нездатність до самообслуговування, самостійного пересування, навчання, трудової діяльності, спілкування, контролю власної поведінки, дезорієнтація, залежність від інших осіб;

II – здатність до самообслуговування з використанням допоміжних засобів та за допомогою інших осіб, здатність самостійно пересуватися з використанням допоміжних засобів та (чи) за допомогою інших осіб, здатність до навчання тільки у спеціальних навчальних закладах або за спеціальними програмами в домашніх умовах, здатність до виконання трудової діяльності у спеціально створених умовах з використанням допоміжних засобів та (чи) спеціально обладнаного робочого місця, за допомогою інших осіб, здатність до орієнтації, що потребує допомоги інших осіб, здатність до спілкування з використанням допоміжних засобів та (чи) за допомогою інших осіб, здатність частково чи повністю контролювати свою поведінку тільки за допомогою сторонніх осіб;

III – здатність до самообслуговування з використанням допоміжних засобів, здатність самостійно пересуватися з тривалішою витратою часу, пересування з зупинками і скорочення відстані, здатність до навчання в навчальних закладах загального типу при дотриманні спеціального режиму навчального процесу та (чи) з використанням допоміжних засобів, за допомогою інших осіб (крім персоналу, який навчає), здатність до виконання трудової діяльності за іншою спеціальністю при відсутності зниження кваліфікації чи зменшенні обсягу виробничої діяльності та неможливості виконання роботи за своєю попередньою професією, здатність до орієнтації за умови використання допоміжних засобів, здатність до спілкування, що характеризується зниженням швидкості, зменшенням обсягу засвоєння, отримання та передання інформації, часткове зниження здатності самостійно контролювати свою поведінку.

Інвалідність (3)

Організація навчання людей з обмеженими можливостями у спільних групах з учнями, студентами без обмежень по здоров'ю – сучасний тренд. Такий підхід сприяє соціалізації та ресоціалізації людей з обмеженими можливостями.

В Україні у різні роки мешкало від 2 до 2,5 млн. інвалідів. Для них передбачали різни пільги та соціальну допомогу, які завжди були недостатніми для доведенняякості життя інвалідів до мінімального українського стандарту. Щоб привернути увагу до проблем інвалідів, у світі проводиться Міжнародний день людей з інвалідністю, щороку 14 жовтня з 1992 року.

Життя інвалідів у сучасному суспільстві полегшують спеціальні комп'ютерні та телекомунікаційні пристрої (наприклад, програми для керування комп'ютером без рук Freetrack), візки, відведення окремих місць у транспорті, будівництво пандусів, синхронний переклад для людей з вадами слуху, але громадський простір України ще недостатньо пристосований для інвалідів, навіть по наявності фізичних бар'єрів пересування.





Практичне заняття 17. Спільне навчання з інвалідами.



Сумний факт полягає в тому, що при спілкуванні із людьми з особливими потребами більшість людей відчувають страх, незручність та огиду. Основна причина такого відношення полягає у незнанні того, що ж таке порушення розвитку і що являють собою люди з особливими потребами. Суспільство старанно приховує від нас наявність проблеми. Серед численних проблем, з якими стикаються батьки дитини з обмеженими потребами можна виділити дві найбільш вагомі. Перша і основна – відношення оточення. Друга – отримання доступної освіти.

Реально отримати освіту можуть лише діти з порушенням зору, слуху, мови, руховими порушеннями і нескладними інтелектуальними порушеннями. Велика кількість дітей не можуть відвідувати спеціальні ЗНЗ через кілька причин. До них належать такі:

1. Як правило, спеціальна школа орієнтується на дітей з певними психофізичними порушеннями.
2. Оскільки кількість дітей із різними порушеннями не може реалізувати свого права на освіту у таких закладах, то для таких дітей передбачено індивідуальна форма навчання.
3. Нема спеціальної програми для навчання таких дітей, адже вона повинна створюватися під кожну, окремо взяту дитину.

Булінг у закладах освіти.

ГОЛОВНЕ В ЗАКОНІ ПРО ПРОТИДІЮ БУЛІНГУ В ШКОЛАХ

Вперше визначено термін:

Булінг – це моральне або фізичне насильство, агресія в будь-якій формі з метою викликати страх, тривогу і підпорядкувати людину своїм інтересам.

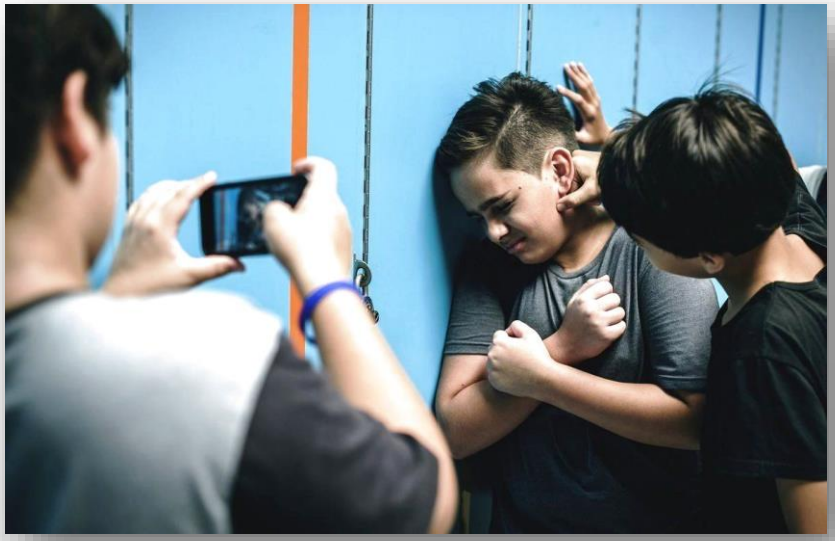
Відповідно до закону №8584



Передбачено відповідальність за знущання:

Моральне або фізичне насильство, агресія	**Штраф 340 – 850 грн**
Дії з особливою жорстокістю, повторне порушення	**Штраф 1700 – 3400 грн**
Приховування вчителем факту цькування	**Штраф 850 – 1700 грн**

За вчинення правопорушення неповнолітніми віком до 16 років – штраф сплачують батьки





Література

- Інклюзивне навчання. МОН України. https://mon.gov.ua/ua/tag/inklyuzivne-navchannya
- Бойчук ЮД. Еколого-валеологічна культура майбутнього вчителя: теоретико-методичні аспекти: монографія. Суми: Університетська книга, 2008. 237 с.
- Билич ГЛ, Назаров ЛВ. Основы валеологии. СПб.: Водолей, 1998. 560 с.
- Красовська ІІ. Сучасні освітні технології навчання. Типи та види уроків, методика їх вибору: метод. порадник. Чернігів, 2010. 40 с.
- Крючек НА, Миронов СК, Мишин БИ. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические рекомендации по оборудованию кабинета ОБЖ в образовательном учреждении. М.: Дрофа, 2005.
- Архітектурна доступність шкіл: навч.-метод. посіб. за заг. ред. Байди Л.Ю., Красюкової-Еннс О.В; колек. авторів: Азін В.О., Грибальский Я.В., Байда Л.Ю., Красюкова-Еннс О.В. К: 2012. 88 с. ISBN 978-966-97179-2-4
- Актуальні питання навчання дітей з особливими освітніми потребами. https://svitppt.com.ua/pedagogika/aktualni-pitannya-navchannya-ditey-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami.html
- Протидія булінгу в закладі освіти: що в законах. https://www.pedrada.com.ua/article/2565-protidya-bulngu-v-zaklad-osvti-shcho-v-zakonah
- Формирование здорового образа жизни у молодежи: Методические рекомендации для учителей средних школ / сост. Шевченко А.С., Орлова Н.А., Кондобаров А.В.; МОМХ, ХРИПОЗ. - Украина, Харьков: СПД-ФО Лысенко А.А., 2004. - 74 с. https://doi.org/10.5281/zenodo.3700597

Лекції 19 та 20.



Психічне та психологічне здоров’я особистості. Професійне вигоряння педагогів.

Психічне здоров’я

План лекції
1. Психічне здоров’я, його медичні критерії.
2. Психічні розлади.
3. Визначення рівню психічного розвитку.
4. Можливості та техніки подолання конфліктів та підтримання емоційної рівноваги.
5. Професійне вигорання педагогів.

Психічне здоров'я – це рівень психологічного благополуччя та відсутністю психічних захворювань, властивістю людини усвідомлення себе як суб'єкта, взаємодіючого з навколишнім світом, орієнтуватися у просторі, часі, самореалізовуватися інтелектуального та емоційно, розвивати здібності (логіку, пам’ять, комунікативні навички), долати життєві труднощі, бар’єри на шляху до цілей, протистояти стресам, продуктивно працювати і робити внесок в свою громаду. Психічне здоров’я тісно переплетене з фізичним. Вони взаємозалежні. Психічно здорова людина вміє адекватно мислити, проявляти емоції, спілкуватися з іншими людьми, заробляти собі на прожиток і отримувати задоволення від життя.

У психічно здорової людини відсутність психічні захворювання та пограничні нервово-психічні розлади, розвиток відбувається гармонійно та відповідає віку, провідні соціальнопрофесійно-значущі психофізіологічні функції забезпечують виконання навчальних, професійних або побутових завдань у повсякденній діяльності. Психологічний стан психічно здорових людей дозволяє досягати емоційної рівноваги та поведінкової адаптації.

Всесвітня організація охорони здоров'я визначає **7 компонентів психічного здоров'я:**
- усвідомлення постійності та ідентичності свого фізичного і психічного Я;
- постійність і однаковість переживань в однотипних ситуаціях;
- критичне ставлення до себе і своєї діяльності;
- адекватність психічних реакцій впливу середовища;
- здатність керувати своєю поведінкою відповідно до встановлених норм;
- планування власної життєдіяльності і реалізація її;
- здатність змінювати свою поведінку залежно від зміни життєвих обставин.

Психічні розлади

Психічні розлади виникають внаслідок вживання психоактивних речовин, розладів настрою (афективні розлади), особистості, поведінки, пам'яті, інтелекту, можуть бути зумовлені стресом та соматичними захворюваннями (органічні, симптоматичні психічні хвороби), неврозами, виникати внаслідок розумової відсталості, ендогенних причин (маніакально-депресивний психоз, шизофренія).

Термін психічний розлад може мати спеціальні визначення у національній юриспруденції, психіатрії та психології. Деякі з психічних розладів виникають на ранньому етапі індивідуального розвитку, інші є результатом соціального життя.

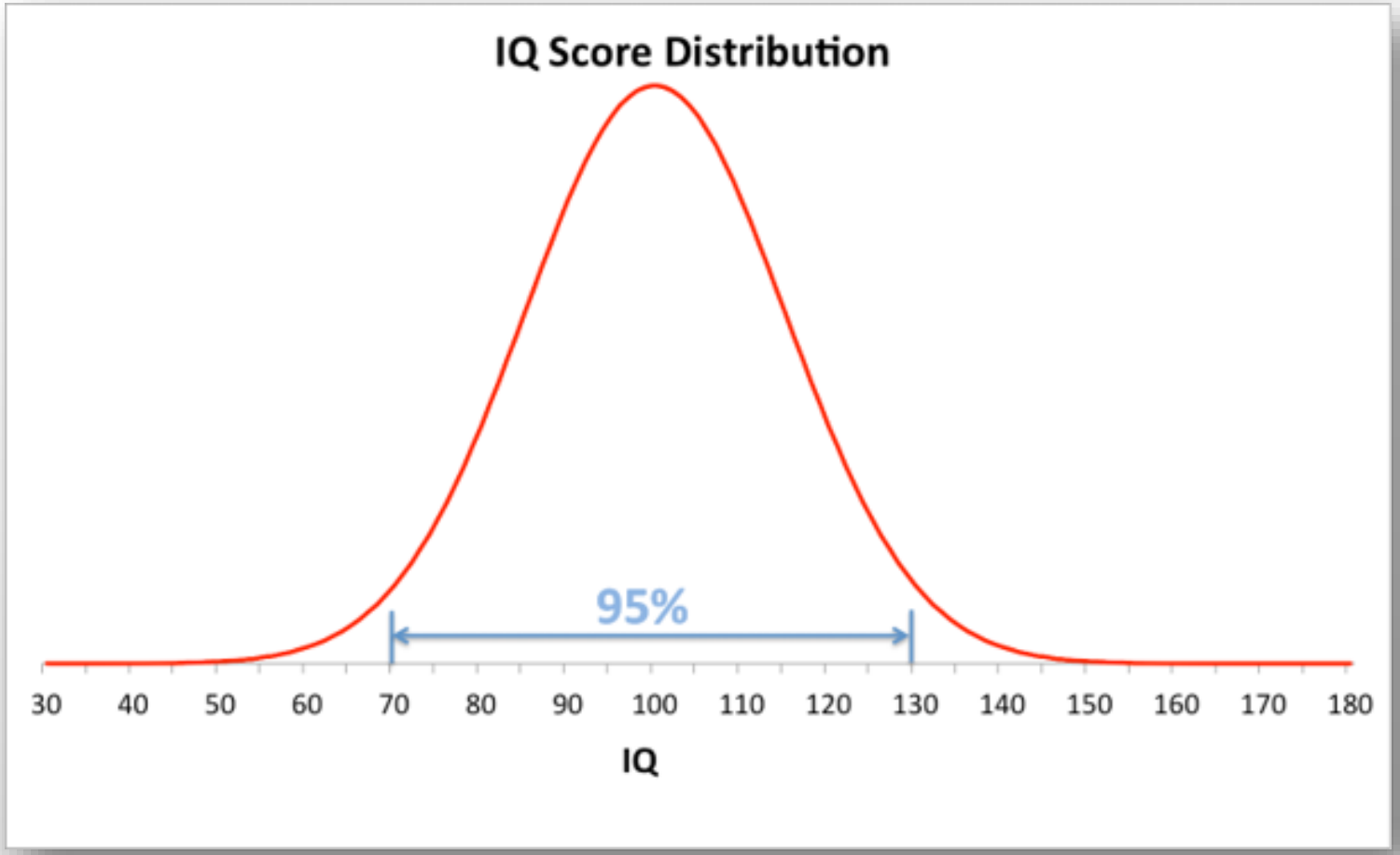




Рівень психічного розвитку визначають за допомогою спеціальних тестів. Тести на визначення **IQ** дають змогу навіть оцінити здібності у балах та порівнювати людей між собою. Не менш важливий показник розвитку – **емоційний інтелект (IE)**, але його у балах не виміряють. Визначення показників інтелекту, пам’яті, психологічних типів доступно не тільки професійним психологам та психіатрам, але і педагогам. Деякі навички (наприклад, управління емоціями та конфліктами) дозволяють краще адаптуватися у житті.



Психічний та психологічний розвиток людини залежить від генетичних факторів, умов життя, соціального оточення та ін. Депресивні стани можуть бути причиною самогубств. Викладачі мають вміти визначати небезпечні психічні та психологічні стани учнів, студентів, щоб запобігти суїцидам.





Коефіцієнт інтелекту (англ. IQ — intelligence quotient) — кількісна оцінка рівня інтелекту людини: рівень інтелекту відносно рівня інтелекту середньостатистичної людини такого ж віку. Визначається за допомогою спеціальних тестів.

Классический IQ тест Ганса Айзенка. Середній IQ випускників американських ВНЗ становить 115, відмінників — 135—140. Значення IQ менше 70 часто кваліфікується як розумова відсталість.

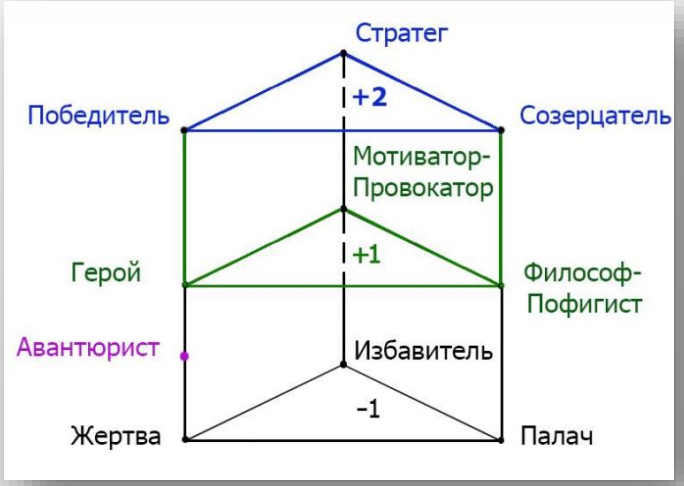
Подолання конфліктів (1)

Для навчання комунікації, самоусвідомлення, подолання конфліктів студентів можуть застосовуватися дієві психологічні прийоми та техніки, відібрані до навчальної дисципліни з курсу **нейролінгвістичного програмування**.

Ролі, що виконуються людьми в родині і робочих колективах, нерідко відповідають моделі, описаній Стівеном Карпманом в 1968 році 1: Жертва, Спаситель і Кат. Входячи в одну з цих ролей, при взаємодії один з одним люди відчувають спектр негативних емоцій, що включає Страх, Жалість, Образу, Гнів, Агресію і Почуття провини. Три перерахованих ролі швидко змінюються: людина переходить з однієї ролі в іншу, іноді кілька разів на хвилину. Схематичне переміщення від ролі до ролі утворює трикутник, який називають двомірним трикутником Карпмана, "трикутником Жертви" або "трикутником страждань". Останнє назва обумовлена сумою емоцій всіх ролей трикутника. Всі емоції трикутника руйнівні для сфери емоційного здоров'я. Відносини між людьми в трикутнику страждань конфліктні.

Саме в таких взаєминах постійно знаходяться 75% всіх жителів планети. Цим пояснюються постійні війни, які супроводжують всю історію людської цивілізації, але також і постійні пошуки гармонії, так як людина прагнути уникати страждань.

Для вивчення ролей трикутника учням і учасником психологічних експериментів С. Карпманом була запропонована рольова гра. Вивчення ролей і емоцій, а також мотивацій учасників трикутника страждань проводилося методами трансактного аналізу, до якого часто вдавався ще один практик-психолог Ерік Берн.



Трансформация ролей в треугольнике Карпмана при переходе с энергетического уровня "+1" на уровень "+2".

Подолання конфліктів (2)

У грі С. Карпмана проводилося моделювання ситуацій, в яких емоції максимально виявлялися. Так створювалися найкращі умови для їх розпізнавання і вивчення. Учасники експерименту також шукали способи перетворення емоцій в інші, менш деструктивні, в дії, а також шукали виходи з трикутника страждань.

В результаті пошуків були знайдені способи 3 рішення проблем:
- Жалість перетворити в Милосердя, а потім в Допомога;
- Образу усвідомити, обговорити, не дозволити їй залишитися прихованою і спровокувати Помста;
- Гнів і Агресію скинути на неживі предмети, сублімувати за допомогою фізичної активності та творчості;
- Почуття провини визнати і "вирівняти" ситуацію за допомогою питань "як я можу це виправити?" і чим я можу допомогти?";
- в разі неефективних спроб трансформації емоцій припинити спілкування з учасниками стійких трикутників страждань.

Професійне вигорання педагогів (1)

«Професійне вигорання» педагога – це синдром фізичного та емоційного виснаження, який включає як розвиток негативної самооцінки й негативного ставлення до роботи, так і втрату розуміння та співчуття по відношенню до учнів.

До основних професійних стресорів педагогічної діяльності спеціалісти відносять: надмірно інтенсивне спілкування; високий ступінь відповідальності за інших людей; інформаційні перевантаження; екстремальні ситуації, які потребують негайного реагування.

Професійне нездоров’я вчителя залежить від багатьох факторів, на які він, на жаль, не здатен вплинути. До таких факторів відноситься феномен емоційного вигорання як результат невідповідності між особистістю та роботою, синдром фізичного й емоційного виснаження, який бере початок зі стресу міжособистісної взаємодії і включає розвиток негативної самооцінки, негативного ставлення до роботи, утрату розуміння та співчуття.

Професійне вигорання педагогів (2)

Емоційне вигорання — це синдром, що розвивається на основі неперервного впливу па людину стресових ситуацій і призводить до інтелектуальної, душевної і фізичної перевтоми та виснаження.

Синдром вигорання включає в себе три основні складові: емоційну виснаженість; деперсоналізацію (цинізм); редукцію професійних досягнень.

Під **емоційною виснаженістю** розуміється відчуття спустошеності і втоми, викликане власною роботою.

Деперсоналізація передбачає цинічне ставлення до роботи та до її об'єктів. Зокрема, в соціальній сфері при деперсоналізації виникає байдуже, негуманне, цинічне відношення до людей, з якими працюють.

Редукція професійних досягнень — виникнення у працівників почуття некомпетентності в своїй професійній сфері, усвідомлення неуспішності в ній.

Існує **три стадії емоційного вигорання:**

Перша стадія. Всі ознаки та симптоми проявляються в легкій формі через турботу про себе, наприклад, шляхом організації частіших перерв у роботі. Починається забування якихось робочих моментів (наприклад, невнесення потрібного запису в документацію). Зазвичай на ці першочергові симптоми мало хто звертає увагу. В залежності від характеру діяльності, сили нервово-психологічних навантажень і особистісних характеристик спеціаліста, перша стадія може тривати три-п'ять років.

Професійне вигорання педагогів (3)

Друга стадія. Спостерігається зниження інтересу до роботи, потреби в спілкуванні (в тому числі, і з близькими): «не хочеться бачити» тих, з ким спеціаліст працює, «в четвер відчуття, що вже п'ятниця», «тиждень триває нескінченно», прогресування апатії до кінця тижня, поява стійких соматичних симптомів (немає сил, енергії, особливо, в кінці тижня, головні болі по вечорах, «мертвий сон, без сновидінь», збільшення кількості простудних захворювань, підвищена дратівливість, людина «заводиться», як кажуть, з півоберта, хоча раніше подібного вона за собою не помічала. Симптоми проявляються регулярніше, мають затяжний характер і важко піддаються корекції. Людина може почувати себе виснаженою після гарного сну і навіть після вихідних. Тривалість даної стадії, в середньому, від п'яти до п'ятнадцяти років.

Третя стадія. Ознаки і симптоми третьої стадії вигорання є хронічними. Можуть розвиватися фізичні і психологічні проблеми типу язв і депресій. Людина може почати сумніватись в цінності своєї роботи, професії та самого життя. Характерна повна втрата інтересу до роботи і життя взагалі, емоційна байдужість, отупіння, відчуття постійної відсутності сил. Спостерігаються порушення пам'яті і уваги, порушення сну, особистісні зміни. Людина прагне до усамітнення. На цій стадії приємнішими є контакти з тваринами і природою, ніж з людьми. Заключна стадія — повне згорання, яке часто переростає в повну відразу до всього на світі. Стадія може тривати від десяти до двадцяти років.

Література

- Коэффициент интеллекта. Википедия. https://ru.wikipedia.org/wiki/Коэффициент_интеллекта
- Коефіцієнт інтелекту. Вікіпедія. https://uk.wikipedia.org/wiki/Коефіцієнт_інтелекту
- Шевченко А.С., Юшко Т.Г. Предотвращение негативных последствий "карпмановских" отношений в медицинских коллективах, между врачами и пациентами / Материалы XVIII научно-практической конференции "Современная наука и ее влияние на развитие человечества" (30.12.2019, г. Харьков, Украина) // Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения. - 2019. - Том 92, № 6. - С. 37-46. https://doi.org/10.5281/zenodo.3526230
- Karpman SB. Fairy tales and script drama analysis. Transactional Analysis Bulletin, 1968;7(26). URL: https://karpmandramatriangle.com/pdf/thenewdramatriangles.pdf
- Berne E. Games People Play. New York: Ballantine Books, 1996. ISBN 978-0-345-41003-0
- Литвинов РН. Код человеческих отношений-1 (часть 1: треугольник страданий, как распознать себя в нем и выйти из него). Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения, 2019;5(91):3-10. https://doi.org/10.5281/zenodo.3553041
- Литвинов РН. Код человеческих отношений-1 (часть 2: новые роли треугольника Карпмана на других энергетических уровнях). Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения, 2019;6(92):30-6. https://doi.org/10.5281/zenodo.3587894
- Професійне вигорання педагога. Психологічна служба профтехосвіти. https://sites.google.com/site/psihologprofteh/metodicna-skarbnicka/profesijne-vigoranna
- МОЗ: Кожні 40 секунд від самогубства помирає одна людина. Galinfo, 10 Жов 2019. https://is.gd/9TxuDd

Практичні заняття 18 та 19.

Невідкладна психолого-педагогічна допомога



Щороку близько 800 000 людей в світі завершують життя самогубством. Це одна з головних причин смертності серед молодих людей віком 15 - 29 років.

Момо та «Сині кити»:
ігри з дітьми,
що призводять
до самогубств.



